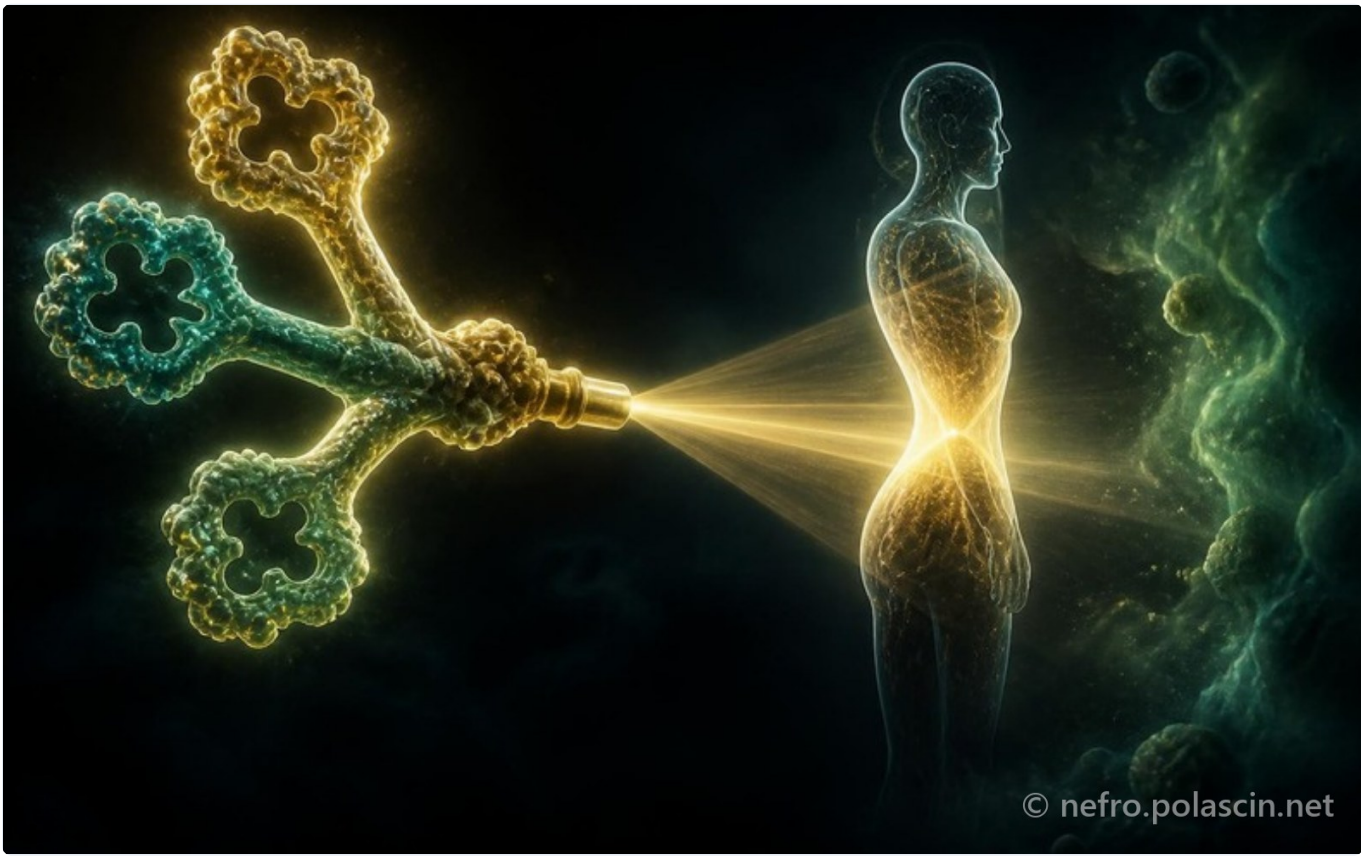
Retatrutid prináša výrazný úbytok hmotnosti aj metabolické benefity. Nové dáta však treba čítať opatrne

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 09.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Trojitý účinok prináša výrazné výsledky – zdržanlivosť si však žiada dĺžka sledovania, nie veľkosť efektu.

Experimentálny liek **retatrutid** priniesol v nových klinických štúdiách výrazný úbytok hmotnosti, zlepšenie kompenzácie diabetu 2. typu a priaznivé zmeny viacerých kardiometabolických rizikových faktorov. Údaje boli prezentované na vedeckom kongrese **American Diabetes Association 2026** v New Orleans. Výsledky štúdie TRANSCEND-T2D-1 boli zároveň publikované v časopise **The Lancet**.

Retatrutid je skúšaný liek zo skupiny terapií s inkretínovým účinkom. Je to **trojitý agonista receptorov GLP-1, GIP a glukagónu**. Kombinácia týchto mechanizmov môže ovplyvniť nielen glykémiu, ale aj telesnú hmotnosť, energetický výdaj a metabolické parametre. Liek však zostáva v štádiu klinického skúšania a jeho miesto v klinickej praxi bude závisieť od ďalších dát, regulačného posúdenia, bezpečnosti a dostupnosti.

Výsledky u pacientov s diabetom 2. typu

V štúdii **TRANSCEND-T2D-1** bolo sledovaných 537 pacientov s nedostatočne kontrolovaným diabetom 2. typu. Vstupná hodnota HbA1c bola v rozmedzí 7,0 až 9,5 %. Účastníci mali BMI aspoň 23 kg/m² a boli randomizovaní na retatrutid v dávkach 4 mg, 9 mg alebo 12 mg, prípadne na placebo.

Po 40 týždňoch sa HbA1c znížil:

- o **1,69 %** pri dávke 4 mg,
- o **1,86 %** pri dávke 9 mg,
- o **1,94 %** pri dávke 12 mg,
- oproti **0,81 %** pri placebe.

Okrem lepšej glykemickej kontroly došlo aj k výraznému poklesu telesnej hmotnosti. Pri najvyššej dávke 12 mg bol priemerný úbytok hmotnosti **15,3 %**, zatiaľ čo pri placebe len **2,6 %**. V absolútnom vyjadrení to pri

najvyššej dávke zodpovedalo približne 16,6 kg (asi 36,6 libry).

Vedúci výskumník štúdie Harpreet Singh Bajaj označil tento rozsah redukcie hmotnosti u ľudí s diabetom 2. typu za mimoriadny, keďže pacienti s diabetom zvyčajne chudnú menej ako ľudia bez diabetu.

Výsledky u ľudí s obezitou bez diabetu

Ďalšie údaje pochádzajú zo štúdie **TRIUMPH-1**, ktorá zahŕňala 2 339 dospelých s obezitou. Účastníci boli rozdelení do skupín s retatrutidom v dávkach 4 mg, 9 mg a 12 mg alebo s placebom.

Po 80 týždňoch dosiahli pacienti užívajúci najvyššiu dávku 12 mg priemerný pokles hmotnosti **28,3 %** (približne 31,8 kg, asi 70 libier). Pri dávke 9 mg bol priemerný úbytok približne 26 % telesnej hmotnosti.

V predĺžení štúdie na 104 týždňov sa úbytok hmotnosti pohyboval od **19,2 %** pri dávke 4 mg až po **30,3 %** pri dávke 12 mg (približne 38,6 kg, asi 85 libier). Viac ako štvrtina účastníkov stratila aspoň 35 % telesnej hmotnosti.

Takéto hodnoty sú pri farmakoterapii obezity neobvykle vysoké. Neznamená to však automaticky, že maximálne chudnutie je vhodným cieľom pre každého pacienta.

Vplyv na osteoartrózu a spánkové apnoe

Štúdia TRIUMPH-1 zahŕňala aj dve vnorené analýzy. Jedna sledovala pacientov s osteoartrózou kolena a druhá pacientov so stredne ťažkým až ťažkým obštrukčným spánkovým apnoe.

Pri osteoartróze kolena retatrutid znížil skóre bolesti podľa indexu WOMAC až o **73,1 %**. Pri spánkovom apnoe znížil index apnoe-hypopnoe (AHI) až o **60,6 %**. Tieto výsledky podporujú myšlienku, že liečba obezity môže ovplyvniť aj jej pridružené komplikácie, nielen samotnú telesnú hmotnosť.

Kardiometabolické benefity

V oboch štúdiách sa pozorovali priaznivé zmeny rizikových faktorov.

V štúdii TRIUMPH-1 bol retatrutid spojený so znížením:

- triglyceridov až o **41,0 %**,
- non-HDL cholesterolu až o **24,2 %**,
- systolického tlaku až o **12,3 mm Hg**,
- obvodu pása až o **24,1 cm**.

V štúdii TRANSCEND-T2D-1 sa zaznamenalo zníženie:

- triglyceridov až o **39,6 %**,
- non-HDL cholesterolu až o **19,8 %**,
- systolického tlaku až o **6,4 mm Hg**,
- obvodu pása až o **12,4 cm**.

Tieto údaje sú klinicky zaujímavé, pretože obezita, diabetes 2. typu, dyslipidémia, hypertenzia a viscerálna adipozita sa často vzájomne posilňujú.

Nežiaduce účinky a nový signál infekcií močových ciest

Profil nežiaducich účinkov bol podobný ako pri iných inkretínových liekoch. Najčastejšie sa objavovali gastrointestinálne ťažkosti, najmä nauzea, hnačka a zápcha. Väčšina bola mierna až stredne závažná a počas liečby ustúpila.

Novým bezpečnostným signálom boli **infekcie močových ciest**. V štúdii TRIUMPH-1 sa vyskytli u 7,5 až 8,8 % pacientov liečených retatrutidom oproti 5,3 % pri placebe. V štúdii TRANSCEND-T2D-1 bol výskyt 0,7 až 2,9 % oproti 0 % pri placebe. Podľa výskumníkov zatiaľ nie je jasné, či ide o náhodný nález, dôsledok hydratácie, zmien diurézy alebo iný mechanizmus.

Prerušenie liečby pre nežiaduce účinky bolo dávkovo závislé. V štúdii TRIUMPH-1 liečbu ukončilo 4,1 % pacientov pri dávke 4 mg, 6,9 % pri dávke 9 mg a 11,3 % pri dávke 12 mg, oproti 4,9 % pri placebe.

Nie je všetko iba o maximálnom chudnutí

Výsledky sú pôsobivé, ale odborníci upozorňujú na potrebu opatrnosti. Rýchly a veľmi výrazný pokles hmotnosti môže mať aj riziká. Otázkou zostáva, u koho je takáto intenzita liečby vhodná, ako dlho má liečba trvať, ako zabezpečiť udržanie účinku a ako sledovať možné nežiaduce následky.

Endokrinologička Alice Y. Y. Cheng upozornila, že väčší úbytok hmotnosti nemusí byť vždy lepší, potrebný ani správny pre každého pacienta. Kľúčovou otázkou podľa nej nie je iba samotné chudnutie, ale **prínos pre zdravie**.

Pri liečbe obezity by cieľom nemalo byť číslo na váhe izolované od klinického kontextu. Dôležité sú metabolické výsledky, funkčný stav, kvalita života, tolerancia liečby, bezpečnosť a dostupnosť.

Záver

Retatrutid patrí medzi najsľubnejšie experimentálne lieky na obezitu a diabetes 2. typu. Dáta ukazujú výrazný úbytok hmotnosti, zlepšenie HbA1c, priaznivý vplyv na lipidy, krvný tlak, obvod pása a potenciálne aj na komplikácie obezity, ako sú osteoartróza kolena a obštrukčné spánkové apnoe.

Zároveň však platí, že ide o liek vo vývoji. Potrebné sú ďalšie údaje o dlhodobej bezpečnosti, udržateľnosti účinku, výbere vhodných pacientov a reálnej dostupnosti. Retatrutid môže byť silným nástrojom, jeho hodnotu však neurčia iba kilogramy, ale najmä to, či pacientom prinesie bezpečný a udržateľný zdravotný prínos.

Zdroj: *Medscape, „Retatrutide Data Show Dramatic Weight Loss, Other Benefits“.* *medscape.com*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=retatrutid-ubytok-hmotnosti-metabolicke-benefity · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.